

UE Approche transdisciplinaire (semestre 2)

Groupe 7: Le virage ambulatoire consiste à remplacer des soins en hospitalisation par des soins ambulatoires. Illustrer ce virage au cours du temps.

Introduction :

Dans le cadre du projet de semestre consacré à l'approche transdisciplinaire à partir des données du SNDS, notre groupe (Groupe 07) a travaillé sur la thématique du virage ambulatoire. Ce virage vise à favoriser la prise en charge des patients en dehors des structures hospitalières, notamment à domicile ou en ville, en s'appuyant sur les professionnels de santé libéraux. Cette orientation s'inscrit dans une logique d'amélioration du parcours de soin, de désengorgement de l'hôpital et d'optimisation des dépenses de santé.

Pour répondre à cette problématique, notre groupe a travaillé à partir des données en open data accessibles sur la plateforme Data Ameli, issues du Système National des Données de Santé (SNDS). Deux ensembles de données ont été utilisés :

- Les données « Data pathologies » pour analyser les prises en charge des patients.
- Les données « Data professionnels de santé libéraux » pour décrire la démographie et l'activité des soignants.

Nous avons choisi de concentrer notre analyse sur les médecins généralistes et les infirmiers, qui sont les principaux acteurs des soins de ville. Le travail a été réparti entre les membres du groupe, chacun ayant exploré une dimension différente du virage ambulatoire, avec des graphiques réalisés à l'aide du logiciel R (packages dplyr et ggplot2).

Travail réalisé au sein du groupe :

Pour ma part, j'ai travaillé sur l'évolution du nombre de professionnels libéraux entre 2016 et 2022, en me concentrant sur les infirmiers et les médecins généralistes, qui sont au cœur du virage ambulatoire. J'ai utilisé plusieurs jeux de données pour extraire des informations pertinentes :

- **Le jeu de données "dr1"**, qui contient la démographie des professionnels de santé, m'a permis d'extraire les effectifs annuels des médecins généralistes et des infirmiers.
- **Le jeu de données "dr2"** a été utilisé pour analyser les montants des honoraires perçus par ces professionnels sur la période étudiée.
- **Le jeu de données "dr6"** a fourni des informations spécifiques sur l'exercice libéral exclusif, permettant de détailler l'évolution de cette pratique professionnelle.

Les résultats montrent une forte augmentation du nombre d'infirmiers libéraux, tandis que le nombre de médecins généralistes reste stable, voire en légère baisse.

On observe également une hausse marquée des honoraires, en particulier chez les infirmiers, ce qui reflète une intensification de leur activité.

L'exercice en libéral exclusif progresse nettement chez les infirmiers, tandis qu'il reste stable et majoritaire chez les médecins généralistes.

Ces tendances confirment que la montée en puissance des soins de ville repose de plus en plus sur les infirmiers pour assurer le suivi des patients en dehors de l'hôpital.

J'ai également rédigé la conclusion finale du projet, en m'appuyant sur l'ensemble des travaux du groupe afin de proposer une synthèse cohérente sur l'évolution du système de santé et les enjeux à venir.

Interprétation et discussion des résultats

Les analyses menées collectivement mettent en évidence plusieurs dynamiques qui témoignent d'une évolution progressive du système de santé vers davantage de soins en ville. Entre 2016 et 2022, les données démographiques montrent une forte augmentation du nombre d'infirmiers libéraux, accompagnée d'une croissance marquée de leurs honoraires. Cela reflète un renforcement de leur rôle dans la prise en charge ambulatoire et à domicile.

Du côté des médecins généralistes, les effectifs restent globalement stables, voire en légère diminution. Leur exercice demeure majoritairement en libéral exclusif, ce qui confirme leur ancrage dans les soins de ville, mais sans dynamique d'expansion comparable à celle observée chez les infirmiers.

Les travaux de l'ensemble du groupe complètent ces constats :

- L'analyse des dépenses de santé met en lumière une progression plus rapide des soins de ville par rapport aux soins hospitaliers.
- Le recours croissant aux soins infirmiers et à l'Hospitalisation à Domicile (HAD) illustre la montée d'alternatives concrètes à l'hospitalisation conventionnelle.
- L'augmentation des honoraires des professionnels libéraux traduit une intensification de leur activité.

Cependant, plusieurs limites doivent être prises en compte. La période étudiée (2016-2022) reste relativement courte pour observer une transformation structurelle d'ampleur. Surtout, les données dont nous disposons ne permettent pas de mesurer directement un transfert d'activité de l'hôpital vers la ville. En effet, nous ne disposons pas d'informations sur l'évolution des prises en charge hospitalières par pathologie ni du nombre de patients concernés, ce qui rend difficile l'identification d'un véritable "remplacement" des soins hospitaliers par des soins ambulatoires.

Ainsi, comme l'a souligné notre enseignant, si les indicateurs disponibles suggèrent une tendance vers un développement des soins ambulatoires, notamment portée par les infirmiers, ils ne permettent pas encore d'affirmer qu'un véritable virage ambulatoire « au sens d'un transfert net et massif des soins » a eu lieu.

Ces résultats posent enfin des questions importantes : comment accompagner cette évolution pour garantir une offre de soins accessible, coordonnée et de qualité ? Cela suppose de renforcer les moyens humains, logistiques et financiers accordés aux soins de ville, tout en veillant à une répartition équitable des professionnels sur le territoire.

Conclusion :

Ce projet m'a permis de mieux comprendre l'évolution du système de santé et le rôle croissant des professionnels libéraux, notamment les infirmiers, dans les soins de ville. Même si les données montrent une croissance, elles ne suffisent pas à prouver un virage ambulatoire complet. Ce travail m'a également permis de développer mes compétences en traitement et visualisation de données, et de participer à une réflexion collective sur les enjeux de la réorganisation du système de santé.